

Eesti vanemaealiste potentsiaali tuleb targalt toetada



Tiina Linno

analüüsi ja statistika osakonna nõunik, sotsiaalministeerium

Sotsiaalministeeriumi vanemaealiste ja eakate toimetuleku 2015. a kordusuuring (edaspidi vanemaealiste uuring), mis keskendus 50aastaste ja vanemate Eesti elanike aktiivsusele ja vajadustele, tõi olulisemate teemadena välja vajaduse pöörata rohkem tähelepanu nii töö- kui pensionialiste vanemaealiste tervisele, töö- ja hoolduskoormusele, heaolule ja turvatundele senisest paremate sotsiaalteenuste ja õigeaegse märkamise kaudu. Eesti vanemaealiste potentsiaal ühiskonda jätkuvalt panustada on küll suur, kuid eirates tänaseid tervise- ja toimetulekumuresid võib see hakata ühel hetkel märgatavalt vähenema.

Uuringut rahastas Euroopa Sotsiaalfond, uuringu küsitlustööd viis läbi TNS Emor, küsitledes üle Eesti 1384 50aastast ja vanemat inimest. Uuringu tulemused on laiendatavad Eesti tavaleibkondades elavatele 50aastastele ja vanematele Eesti elanikele.

Vanemaealiste üldine hõivatus ja potentsiaal

Sotsiaalministeeriumi vanemaealiste uuringu üheks eesmärgiks oli vaadelda vanemaealiste aktiivsust võimalikult avaralt, et mõista nii seda, millega vanemaealised päevast päeva tegelevad – ka pärast seda, kui nad on tööturult

lahkunud –, kui ka seda, milline on nende huvi ja potentsiaal erinevate tegevuste kaudu ühiskonda panustada. Ehk teisiti öeldes, tööturult kas omal algatusel või olude sunnil taandumine ei muuda inimest „nähtamatuks”, vaid ta valib teised tegevused, ja selleks on ka kindlad põhjused. Nende põhjuste ja valikute uurimine loob eeldused mõistmaks paremini asjaolusid, mis võimaldaksid inimesi soovi korral nii tööturule tagasi aidata kui ka hoida neid võimalikult kaua ühiskonnas aktiivsena. Seetõttu on oluline märgata vanemaealisi mitte ainult tööturul tasustatud töö, vaid ka tasustamata vabatahtliku töö tegijate, teistele inimestele mitmekülgse abi pakkujate ning igas mõttes aktiivsete ühiskonnaliikmetena.

Uuringu andmetel oli tavaleibkonnas elavatest 50aastastest ja vanematest Eesti elanikest (edaspidi vanemaealistest), keda Statistikaameti andmetel oli 2015. aastal ligi 500 000¹, 43% hõivatud tasustatud ja 14% tasustamata vabatahtliku tööga. Teiste abistamisega oli erinevate tegevuste kaudu kõige laiemal määral² seotud 80% vanemaealistest, seejuures mehed ja naised võrdselt. Eraldi uuriti seotust heategevusega, millega tegeles enda hinnangul 39% vanemaealistest. Arvestades, et üheainsa protsendi taga on

¹ Statistikaameti andmed seisuga 01.01.2015.

² Laiemas mõttes abistamise alla kuulub ka abistamine, mis ei võta olulist osa vastaja ajast.

antud juhul ligi 5000 inimest, näitavad need tulemused vanemaealiste suurt panust Eesti ühiskonnaellu juba praegu.

Lisaks ei teinud vabatahtlikku tööd, kuid oli sellest huvitatud 9% vanemaealistest. Sama palju oli neid, kes ei olnud tegelnud heategevusega, kuid leidsid, et võiksid seda teha. Mis puudutab kasutamata potentsiaali teiste inimeste abistamises, siis täiendavalt 13% vanemaealistest võiks enda hinnangul tegelda laste hoidmisega (juba tegeleb 38%), puudega lapse hooldamisel oleks nõus abistama 3% (tegeleb 2%), sama palju hooldaks puudega tööealist inimest (tegeleb 4%). Terviseprobleemiga tööealist inimest võiks hooldada 5% (juba teeb seda samuti 5%) ning pensionieas puude või terviseprobleemiga täiskasvanut 4% (tegeleb 16%). Lisaks võiksid vanemaealised täiendavalt pakkuda kas seltsi, teisi ära kuulata ja nõu anda või abistada inimesi muul moel. Mõistagi eeldavad abipakkujad, et nende tegevus oleks vabatahtlik ning nad saaksid teha seda sel ajal ja sellisel määral, mis ei takistaks neil tegelemist ka isiklike asjadega, sh tööl käimist või hobisid.

Abistamis- ja hoolduskoormus

Alati ei ole aga võimalik teiste abistamisel piirduda abistajale sobiva koormusega. Seetõttu on oluline abistamise laiemast mõistest eristada need vanemaealised, kelle hinnangul abistamine või hooldamine võtab olulise osa nende ajast ning kelle isiklik toimetulek võib hakata seetõttu kannatama. Kitsendades küsimust määrani, kus need kohustused võtavad inimese hinnangul juba olulise osa tema ajast, selgus, et seda teeb pea iga viies Eesti vanemaealine (19%) ehk kokku ligikaudu 95 000 Eesti 50aastast ja vanemat inimest. Erinevate vanuserühmade üldist hoivatust võrreldes on näha, et alates 65. eluaastast hakkab nii tasustatud kui

tasustamata tööga hoivatute osakaal märgatavalt langema, samas väheneb märksa aeglasemalt nende hulk, kes olulisel määral teisi abistavad: 65–69aastastest teeb seda 18%, mis on ligilähedane 50–54aastastega (22%), 70–74aastastest abistab teisi olulisel määral 15% ning isegi 75–79aastastest 11%; alles alates 80. eluaastast langeb olulisel määral abistajate osakaal 4%le.

Teisi olulisel määral abistavatest vanemaealistest teeb 52% seda kõrge koormusega ehk neil kulub selleks 20 või enam tundi nädalas. Seejuures 25%l vanemaealistest ja 20%l töötavatest tööealistest selles grupis kulub selleks enda hinnangul üle 40 tunni nädalas ehk need inimesed panustavad abistamisse sisuliselt (teise) täistööaja või veelgi rohkem. Keskmise koormusega ehk 10–19 tundi nädalas abistab kedagi 14% ning madala koormusega ehk kuni 10 tundi nädalas 25% selle grupi vanemaealistest (9% ei osanud öelda või keeldus vastamast). Olulisel määral abistavate naiste hulgas on meestega võrreldes suurem ka suure koormusega (20+ tundi) abistajate hulk, vastavalt 57% ja 41%. Naiste hulgas on seejuures oluliselt rohkem üle 40 tunni nädalas abistajaid (31% vs 13%) ehk paljud neist tunduvad tegelevat kellegi ööpäevaringse abistamise või hooldamisega.

Kõige suurem koormus kaasneb puudega tööealiste või pensionieas täiskasvanute hooldamisega: vastavalt 87% ja 76% vanemaealistest, kellelt see võtab oluliselt aega, kulutavad sellele nädalas 20 või enam tundi. Aga ka teised tegevused, nagu terviseprobleemidega tööealiste või puudega laste hooldamine, võtavad enam kui pooltel juhtudest nädalas üle 20 tunni. Laste hoidmine võtab üle 20 tunni nädalas 66%l neist, kes teisi olulisel määral abistavad.

Abistamis-hoolduskoormus on suurim 55–59- ja 60–64aastastel, kellest vastavalt 28% ja 25% võtab teiste abistamine olulise osa ajast.

55–59aastased tegelevad teistest vanuserühmadest enam puude või terviseprobleemiga pensionieas täiskasvanute hooldamisega (üldse tegeleb 20% vanuserühmast, olulise osa ajast võtab 9%), samuti teiste inimeste ärakuulamise ja neile nõu andmisega (üldse 73%, olulisel määral 12%). Sellele vanuserühmale langeb ilmselt suures osas oma eakate vanemate eest hoolitsemise kohustus. 60–64aastased tegelevad keskmisest enam laste hoidmisega (üldse 53%, olulisel määral 12%) ning terviseprobleemidega tööelise inimese hooldamisega (üldse 12%, olulisel määral 2%).

Kõigist kedagi abistavatest või hooldavatest vanemaealistest (ca 400 000) 14% on enda hinnangul pidanud selle tõttu viimase 24 kuu jooksul millestki loobuma või isiklikke tegevusi vähendama. Ennekõike on see kohustus mõjutanud võimalust tegelda isiklike või perekondlike tegevustega (14%). Mõju töötamisele viimase kahe aasta jooksul on olnud tunduvalt väiksem: 2% on vähendanud töökoormust, 1% vahetanud töökohta ning 1% loobunud töötamisest. Kuid jällegi on oluline teada, et selliste väikeste osakaalude taga on päris suur arv inimesi (antud juhul on 1% ca 4000 inimest), kelle töötamist ja isiklikku elu teiste abistamine või hooldamine on hakanud häirima. Kokkuvõtvalt on nendeks suurema tõenäosusega kõrge hoolduskoormusega, suurema tööalase koormusega, naissoost, suuremates leibkondades elavad, kuid väheste leibkonnast väljaspool elavate lähedastega, puudeta ja sotsiaalteenuseid mittekasutavad vanemaealised.

Vanemaealiste tervis

Lisaks eespool kirjeldatud tegevustele ja koormusele on vanemaealiste tervis see, mis tegelikult enim mõjutab nii nende aktiivsust tööturul kui ka ühiskonnaelus osalemist ja eluga rahulolu üldse. Sarnaselt Statistikaameti andmetega viitab vanemaealiste uuring

asjaolule, et alates 55. eluaastast suureneb oluliselt nende inimeste osakaal, kes hindavad oma tervist kas halvaks või väga halvaks: kui 2015. a oli 50–54aastaste hulgas selliseid inimesi 12%, siis alates 55. eluaastast kasvas nende osakaal ca 20%ni ja püsis sellisena kuni 69. eluaastani. Vanuses 70–74 kasvas halva või väga halva tervisega inimeste osakaal 26%ni, vanuses 75–79 35%ni ning alates 80. eluaastast koguni 46%ni. Kroonilisi haigusi põdes seejuures pea kaks kolmandikku vanemaealistest, ligi veerandil oli puue ja viiendik koges terviseprobleemi tõttu igapäevaselt olulisi tegevuspiiranguid.

Eeltoodut arvestades on ootuspärane, et 39% ennetähtaegselt vanaduspensionile jäänud inimestest nimetas selle peamise põhjusena just isiklikke terviseprobleeme või puuet, mis ei võimaldanud töötamist jätkata. Sama tõi mittetöötamise põhjusena välja ka 34% kõigist mittetöötavatest ning 58% tööelimest mittetöötavatest vanemaealistest. Kui lisada asjaolu, et liiga suur koormus lähedaste aitamisel või hooldamisel mõjutab samas viimastest vähem kui 10%, siis on selge, et inimese enda tervis, eriti selle hoidmine vanemas eas on prioriteet number üks. Otseselt panustab parem tervis vanemaealiste inimeste tööalase ja muu aktiivsuse säilimisele, teiselt poolt ja kaudsemalt aga ka nende hoolduskoormuse vähenemisele, sest hooldamist vajavate inimeste, sh eakaaslaste hulk ühiskonnas selle kaudu ju samuti väheneb.

Tööle tagasipöördumine ja töötamise jätkamine pensionieas

Tööga mittehõivatud tööeas vanemaealistest oleks valmis tööle tagasi pöörduma 58%, pensionialalistest 11%, seejuures 18% 65–69aastastest. Neist, kes oleksid valmis tööle tagasi pöörduma, vajab 60% enda hinnangul informatsiooni pakutavatest töökohtadest, 22%

ümberõpet uue elukutse omandamiseks ning 22% tuge oskuste saamiseks, et leida sobiv töökoht. Töö- ja pensioniealiste vajadused on üldjoontes samad, vaid vajadust täiendusõppeks viimati omandatud elukutsel töötamiseks rõhutavad tööealised enam kui pensioniealised (vastavalt 19% ja 7%).

Tänastest tööeas ja töötavatest vanemaealistest kavatseb vanaduspensioniea saabudes enda hinnangul töötamist jätkata 75%, seejuures kindlasti 30%. Jätkamisest ei ole huvitatud viiendik. Töötamise jätkamine on taas seotud inimese tervisega: kindlasti ei jätkata 35% halva või väga halva tervisega ning 31% puudega tööeas töötavatest vanemaealistest.

Teenused töötamiseks ja toimetulekuks

Lisaks tööle tagasipöördumise teenustele vajavad vanemaealised abi ja teenuseid ka tööturul püsimiseks või toimetulekuks üldisemalt. 2015. aastal oli viimase 12 kuu jooksul mõnda hoolekandeteenust kasutanud 4% kõigist vanemaealistest, seejuures 50–74aastastest 3% ning 75aastastest ja vanematest 10%. Enim kasutati koduteenust, sotsiaaltransporti ja isiklikku abistajat, samuti külastati päevakeskusi ning saadi sotsiaalnõustamise ja koduõenduse teenuseid. Hoolekandeteenuste kasutajatega võrreldes oli mõnevõrra rohkem vanemaealisi (13%), kes viimase 12 kuu jooksul olid pöördunud abi saamiseks mõne kohaliku omavalitsuse töötaja poole. Neid vanemaealisi, kelle poole sotsiaaltöötaja ise abi pakkumiseks pöördus, oli 5%. Samas oli 9% neid, kelle poole sotsiaaltöötaja ei pöördunud, kuid kes enda hinnangul oleksid abi vajanud.

Taustaks on oluline teada, et samal ajal kui viiendik vanemaealistest arvab, et kohalik omavalitsus pöörab oma piirkonna vanemaealiste toimetulekule ja ühiskonnaelus osalemise võimalustele piisavalt tähelepanu, leiab täpselt sama suur hulk, et see tähelepanu on ebapiisav.

Konkreetsed hoolekandega seotud ettepanekuid esitas 13% vanemaealistest, kellest pooled arvasid, et sotsiaalteenuste korraldus vajab parandamist: suur osa neist viitas taas sellele, et kohalik omavalitsus peaks oma piirkonna vanemaealiste toimetulekule rohkem tähelepanu pöörama, hoidma nendega tihedamat kontakti, kaardistama inimeste vajadusi, et neid paremini mõista ning informeerima neid olemasolevatest teenustest ja nende osutamisega seotud muudatustest. Probleemina toodi välja, et kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja ei reageeri alati (piisavalt kiiresti) abivajajate palvetele. Hoolekandeteenustest, millega kohalik omavalitsus saaks vanemaealisi aidata, mainiti eelkõige koduteenust (18%), sotsiaaltransporti (17%), erinevaid hooldusteenuseid (8%) ja isiklikku abistajat (8%).

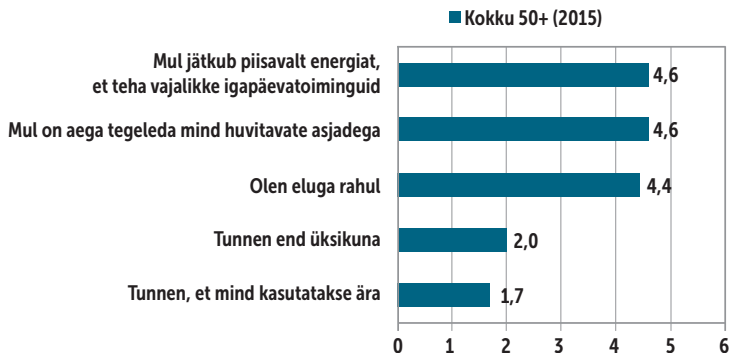
Vanemaealistest, kes kõige laiemas mõttes kedagi abistavad või hooldavad, vajaks selleks lisaabi 12%. Abivajajate hulgas on enam eakaid (25% üle 80aastastest), puudega (27%) ja halva tervisega (26%) vanemaealisi, töövõimetuspensionäre (18%) ning naisi (15%). 63% lisaabi vajajatest oskas nimetada ka konkreetseid hoolekandeteenuseid, neist ligikaudu pooled nimetasid samuti vajadust koduteenuse järele, mis hõlmaks nii kodu- kui ka isikuabi; ligi veerand vajaks isikliku abistaja teenust ning veidi üle viiendiku sotsiaaltransporti, et käia arsti juures, poes ja mujal või transportida sinna hooldatavat inimest; 12% tundis puudust abilisest, kes annaks neile kas igapäevaselt või pikemaks perioodiks puhkust teise isiku hooldamisest. Lisaks eeltoodule nimetasid teiste abistajad vajadust abi järele suuremate majapidamistöõde tegemisel nagu muru niitmine, küttepuude varumine ja riita ladumine ning kodused remonditööd, samuti vajadust teenuseid puudutava info, aga ka lihtsalt seltsi järele.

Telekommunikatsioonitehnoloogiatega kasutamine vanemaealiste poolt on võrreldes

2009. a vanemaealiste uuringuga ehk viimase kuue aasta jooksul märgatavalt kasvanud, mis on hea uudis e-teenuste arendajatele. Esmakordselt uuriti 2015. aastal vanemaealiste huvi ja vajadust häirenupu³ ja teleteenuste⁴ järele. Kuigi nende teenuste kasutajate hulk on Eestis veel väike (vastavalt 4% ja 1%), on huvi nende kasutamise vastu tulevikus üllatavalt suur. Häirenuputeenusega liitumisest oleks huvitatud 16% kõigist vanemaealistest, seejuures 24% 80aastastest ja vanematest. Teleteenustest oleks huvitatud 36%, seejuures kohe kasutaks seda 4–6% kõigust vanuserühmadest. Huvi teenust edaspidi kasutada on suurem aga nooremates vanuserühmades, mistõttu 50–64aastaste huvi teleteenuse vastu tervikuna on võrreldes 70aastaste ja vanematega ka kõrgem (vastavalt 44...49% ja 18...29%).

Elukvaliteet ja aktiivsus

Kuigi eespool selgus, et Eesti vanemaealiste tervis hakkab 55. eluaastast halvenema ning samal ajal on ka teiste abistamise ja hooldamisega seotud koormus märkimisväärtne, ollakse oma eluga üsna rahul (vt ka jooniseid 1 ja 2). Keskmine hinnang eluga rahulolule 1–6pallisel skaalal (1 on madalaim ja 6 kõrgeim hinnang) on 4,4. Seejuures 5–6 palliga hindab eluga rahulolu 52% kõigist vanemaealistest, 58% töötavatest tööelistest, 63% töötavatest pensioneerlastest ning 70% hea või väga hea tervisega inimestest, mis taas viitab asjaolule, kuivõrd olulised on vanemas eas nii tervis kui materiaalne kindlustatus. Lisaks näitavad uuringu andmed, et eluga rahulolu sarnaneb kõigi vanemaealiste keskmisega (4,4 palli) vanuses 50–59, tõuseb veidi vanuses 60–69 (4,5), saavutab maksimumi 70–74aastaste



ALLIKAS: VANEMAEALISTE TOIMETULEKU UURING 2015

Joonis 1. Hinnangud rahulolule eluga (1). Keskmine hinnang skaalal 1 – mitte kunagi ... 6 – väga tihti

³ Häirenuputeenuse osutamiseks antakse isikule kas käel või kaelas kantav häirenupuga seade, mida inimene saab kasutada hädaolukorras ning millele vajutades edastatakse kokkulepitud kontakttelefonidele teade isiku abivajadusest. Samuti paigaldatakse vajadusel inimese eluruumidesse positsioneerimiseadmed ning erinevad andurid (nt kukkumisandur), mis reageerivad tema liikumisele ning vajadusel samuti abi kutsuvad.

⁴ Teleteenuste kaudu on inimesel võimalik oma kodus televiisori või spetsiaalse puutetundliku arvutiekraani kaudu suhelda nii oma sotsiaaltöötaja, lähedaste ja tuttavatega ning osaleda erinevates suhtlemist ja füüsilist pingutust nõudvates tegevustes, mis hõlmavad näiteks tervisega seotud probleeme, mälu treeningut, kultuuri ja päevakajalisi teemasid ning kehalist tegevust.

hulgas (4,6) ning hakkab pärast seda taas langema, eriti alates 80. eluaastast (4,2). Eeltoodule täienduseks on väga rõõmustav, et valdav enamus vanemaealistest tunneb end oma kodus hästi (5–6 palli annab 91%) ning tõdeb, et suhted pereliikmete ja lähedastega pakuvad rahulolu (5–6 palli annab 84%).

Nagu eespool selgus, on suur osa vanemaealistest vajadusel vägagi valmis teisi inimesi toetama või vajadusel ka nende eest hoolitsema (5–6 palli andis 49%). Taas eristuvad siin töötavad töö- ja pensioniealised (5–6 palli andsid vastavalt 60% ja 61%) ning hea või väga hea tervisega inimesed (5–6 palli andsid 67%).

Seejuures hinnatakse sama oluliseks vanemaealiste võimalusi olla neile sobival

viisil aktiivne ka neid huvitavates tegevustes. Kokkuvõtvalt võib vaba aja veetmise kohta öelda, et koduste hobidega tegelda ning vabas õhus mõõdukat füüsilist tööd teha saab ligikaudu kaks kolmandikku, mõõdukalt sportida aga ligi pooled vanemaealistest nii palju kui nad seda soovivad. Samas on nii sportimine kui sugulaste, sõprade ja tuttavate külastamine need tegevused, millega ligi kolmandik vanemaealistest tegeleks võimalusel senisest enam. Enim tuntakse puudust kultuuriürituste külastamisest ning reisimisest Eestis ja välismaal, millega võimalusel sooviks senisest enam tegelda 40–50% vanemaealistest. Sellega, et isiklikult suudetaks ühiskonnaellu panustada enam kui praegu,



ALLIKAS: VANEMAEALISTE TOIMETULEKU UURING 2015

Joonis 2. Hinnangud rahulolule eluga (2). Keskmine hinnang skaalal 1 – ei nõustu üldse ... 6 – nõustun täielikult

kui antaks võimalus seda teha, vanemaealised pigem ei nõustu (3,3 palli skaalal 1...6, kus 1 tähendas täielikku mitte-nõustumist ja 6 täielikku nõustumist väitega „Tunnen, et suudaksin panustada ühiskonda rohkem kui

mulle praegu antakse võimalust seda teha”). Samas oli palju neid, kes nõustusid sellega, et aktiivsena vananemist toetavaid hoiakuid tuleb Eesti ühiskonnas senisest aktiivsemalt kujundada (5 palli).

S

Põhjalikuma ülevaate vanemaealiste toimetulekust, vajadustest, aktiivsusest ja elukvaliteedist (koos 2009. a uuringu võrdlustega) saab uuringu lõpparuandest, mille koostasid TNS Emor ja Poliitikauuringute Keskus Praxis ning mis on leitav sotsiaalministeeriumi veebilehel: Uudised, pressinfo -> Uuringud ja analüüsid -> Sotsiaalvaldkond -> Vanemaealiste ja eakate toimetuleku uuring 2015.